随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

VS 肺型P波:右心房大 又长高了 高尖P波

（四）检查

①**超声心动图（首选和金标准）**：城墙样、穹顶状、鱼钩样、鱼嘴样（城墙穹顶钓鱼）

②心电图：二尖瓣型 P 波（**P 波增宽＞0.12s 常呈双峰状**）

本质左房大

P波代表心房去极化 说明左心衰 右房 左房

左心房去极化本来就慢于右心房 现在左心房变大以后就更慢了

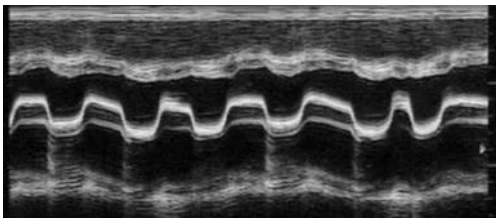
①慢慢压

③X 线：

肺淤血肺水肿的表现	肺门增大、上肺纹理增多 ① **KerleyB 线**（**慢**性间质性肺水肿）、**肺门蝴蝶征**（**急**性肺泡性肺水肿） ②
左心房扩大的表现	双心房影、**梨形心**、食管下段受压

正常情况下,下肺纹理比上肺纹理多,淤血时下肺纹理压力更高 启动机体保护性收缩,把一部分的血液匀到上肺纹理

只有二尖瓣狭窄是梨形心



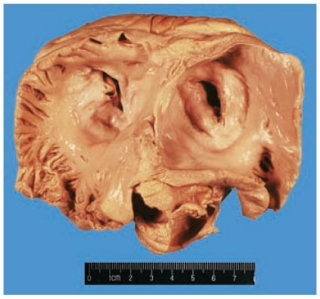
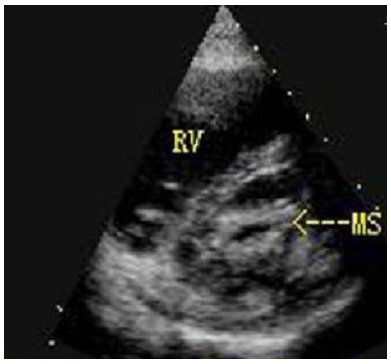
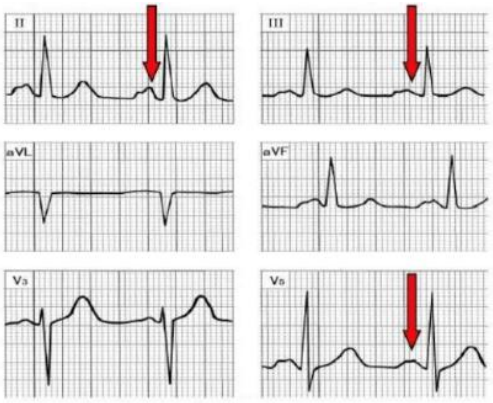
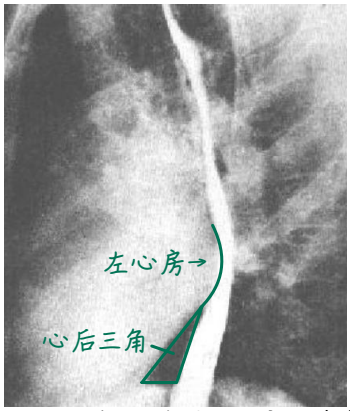


图 9-26　心瓣膜病
二尖瓣呈鱼口状狭窄。

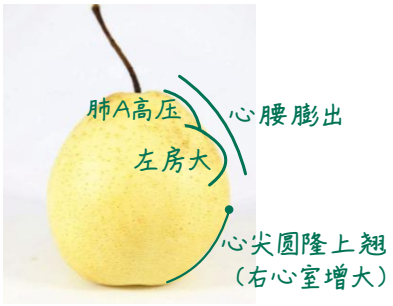






看到心后三角就说明左心室没有变大







急性左心衰

（五）治疗 急性左心衰治疗:强心、利尿、扩管、打吗啡

1.**二尖瓣狭窄并发急性肺水肿**

①**用硝酸酯类、呋塞米** 扩V减少回心血量,利尿剂整体减少血容量,也使回心血量↓

②**禁用硝普钠、强心苷（窦性心律）** 强心苷抑制房室结,减少心房冲动往心室传 适合伴有房颤、阵发性室上速的患者(二狭伴有房颤可用)

本就没血可射,扩动脉导致休克出现